Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Lifting cervical profond

Lifting du cou traitant également les structures profondes du cou (lifting cervical en plan profond)

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Composantes prévues :
☐ Platysmaplastie ☐ Retrait de la graisse profonde
☐ Réduction des muscles digastriques
☐ Réduction de la glande sous-mandibulaire ☐ Excision de peau

Lifting du visage simultané : ☐ Non ☐ Oui (avec un formulaire de consentement distinct)

_____

Autres interventions à réaliser en même temps : _____

Préoccupations et attentes du patient : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

Avec l'âge, les variations de poids ou des caractéristiques héréditaires, le cou peut présenter une **plénitude sous le menton**, une perte de l'angle entre la mâchoire et le cou, des **bandes verticales** (bandes du muscle platysma) et une **peau relâchée**. Cet aspect est souvent dû non seulement à la graisse située sous la peau, mais aussi à **la graisse profonde située sous le muscle du cou, aux muscles sous le menton (muscles digastriques) et à l'affaissement des glandes salivaires (glandes sous-mandibulaires)**.

Le lifting cervical profond traite également ces structures profondes, dans le but de dessiner l'ovale du visage et d'obtenir un cou **plus jeune, plus net et d'aspect naturel**. Le résultat dépend de l'élasticité de votre peau, de votre structure osseuse, de votre poids et de votre âge. L'intervention n'arrête pas le vieillissement ; le cou continuera à se relâcher progressivement avec le temps.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

L'intervention est généralement réalisée sous anesthésie générale, au bloc opératoire. Au préalable, votre cou est examiné en position assise et debout, photographié et marqué, et les structures à traiter sont convenues avec vous.

1. **Incisions :** Une incision d'environ 3 à 5 cm est réalisée dans le pli naturel sous le menton. Si un excès de peau doit être retiré, des incisions sont ajoutées autour du lobe de l'oreille et se prolongent derrière l'oreille vers la lisière des cheveux. Les incisions sont dissimulées autant que possible dans les plis naturels et dans le cuir chevelu.
2. **Décollement de la peau :** La peau du cou est délicatement séparée du muscle sous-jacent ; si nécessaire, la graisse superficielle est amincie de manière homogène.
3. **Retrait de la graisse profonde :** La graisse profonde située sous le muscle du cou (platysma), qui ne peut pas être atteinte par une liposuccion depuis l'extérieur, est réduite de manière contrôlée.
4. **Muscles digastriques et glandes sous-mandibulaires :** Si nécessaire, la partie antérieure du muscle digastrique responsable de la plénitude sous le menton est amincie. Si une glande salivaire (glande sous-mandibulaire) est affaissée et proéminente, la partie saillante peut être partiellement réduite ; la glande n'est pas retirée en totalité.
5. **Platysmaplastie :** Les bords du muscle platysma, qui se sont écartés au milieu du cou et forment des bandes, sont suturés ensemble pour créer un « corset interne » ; si nécessaire, le muscle est également suspendu par les côtés.
6. **Retrait de l'excès de peau et fermeture :** La peau est redrapée vers le haut et vers l'arrière, sans tension, et l'excédent est retiré. Le saignement est soigneusement contrôlé, un **drain** (un fin tuyau servant à évacuer le liquide) est généralement mis en place, les incisions sont refermées par des points fins et un pansement du cou est appliqué.

Les composantes prévues varient d'une personne à l'autre ; toutes les étapes ne sont pas réalisées chez chaque patient. Si un lifting du visage doit être réalisé en même temps, un **formulaire de consentement distinct** sera signé pour celui-ci.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale (chez certains patients, sédation + anesthésie locale)	Environ 2 à 4 heures (plus longtemps en cas d'interventions associées)	Généralement une nuit à l'hôpital

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Un ovale du visage et un angle entre la mâchoire et le cou mieux dessinés
- Moins de plénitude sous le menton et moins de bandes verticales sur le cou
- Raffermissement de la peau relâchée du cou et un aspect plus jeune et plus frais

La plupart des patients correctement sélectionnés sont satisfaits du résultat. La majeure partie du gonflement disparaît au cours des 4 à 6 premières semaines ; le résultat définitif est visible en **6 à 12 mois**. Les résultats peuvent être plus limités chez les patients ayant une peau de mauvaise qualité, un âge avancé, une perte de poids importante ou des antécédents de chirurgie du cou. Environ **5 à 10 patients sur 100** peuvent avoir besoin d'une petite intervention de correction (retouche).

4 Autres options thérapeutiques

- **Ne pas se faire opérer :** Comme il s'agit d'une intervention esthétique, vous avez toujours la possibilité de ne pas la faire.
- **Liposuccion sous-mentonnière (du menton) seule :** Peut suffire chez les personnes ayant une bonne élasticité cutanée et dont la plénitude est due uniquement à la graisse située sous la peau ; elle ne corrige pas la graisse profonde, les muscles ni les glandes.
- **Injections lipolytiques (acide désoxycholique) ou appareils à base d'énergie (radiofréquence, ultrasons) :** Apportent une amélioration limitée en cas de plénitude et de relâchement légers ; plusieurs séances sont généralement nécessaires.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Toxine botulique pour atténuer les bandes du platysma :** Réduit les bandes de façon temporaire (3 à 4 mois) ; elle ne corrige ni l'affaissement ni la graisse.
- **Un lifting du cou plus limité :** Interventions plus légères qui retirent uniquement l'excès de peau ou comprennent uniquement une platysmaplastie ; leur effet est plus limité.

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si l'intervention n'est pas réalisée, l'aspect actuel de votre cou persistera et le vieillissement naturel se poursuivra. Cela ne représente aucun risque pour votre santé.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Des analyses de sang et, si nécessaire, un ECG et d'autres examens sont réalisés avant l'intervention ; vous serez examiné(e) par le médecin anesthésiste.
- **Il est très important que votre tension artérielle soit bien contrôlée.** Une tension artérielle élevée augmente nettement le risque d'accumulation de sang dans le cou (hématome) après l'intervention. Demandez au médecin anesthésiste si vous devez également prendre votre médicament contre la tension le matin de l'intervention (avec une gorgée d'eau).
- Ne mangez et ne buvez rien pendant les **6 à 8 heures** précédant l'intervention (suivez les consignes du médecin anesthésiste).
- Évitez le sport intense, le sauna et une consommation importante d'alcool avant l'intervention. Ne portez ni maquillage, ni bijoux, ni collier le jour de l'intervention ; apportez un haut qui se boutonne sur le devant et qu'il n'est pas nécessaire d'enfiler par la tête.
- Il est recommandé qu'une personne reste avec vous pendant les 24 à 48 premières heures après l'intervention.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Premières 24 à 48 heures	Vous aurez un pansement et un drain sur le cou. Vous ressentirez un gonflement, une sensation de tiraillement et une gêne en avalant ; la douleur est généralement légère à modérée. Il est important de dormir la tête surélevée (30–45°), de ne pas trop fléchir le cou et d'éviter les poussées de tension artérielle (ne pas forcer en poussant, maîtriser une éventuelle toux). Le drain est généralement retiré **le 1er ou le 2e jour**.
1re semaine	Le gonflement et les ecchymoses, **si elles apparaissent**, sont à leur maximum à ce stade, puis commencent à diminuer. Un engourdissement du cou et de la zone sous le menton est normal. Le **vêtement de contention/pansement du cou** est porté jour et nuit selon les consignes. Les points sont retirés **entre le 5e et le 10e jour**.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2e à 4e semaine	La plupart des patients reprennent un travail de bureau et leur vie sociale en 10 à 14 jours. Une induration, une sensation d'irrégularité et un tiraillement du cou peuvent persister. Le sport intense, le fait de se pencher, de soulever des charges et les mouvements qui sollicitent le cou doivent être évités pendant au moins **3 à 4 semaines**.
1er au 3e mois	Le gonflement et l'induration résiduels diminuent progressivement. L'engourdissement s'améliore en grande partie. Les cicatrices peuvent être rosées et légèrement en relief pendant cette période.
6e au 12e mois	L'aspect définitif est visible ; les cicatrices s'estompent et s'affinent. Si une retouche est jugée nécessaire, elle est généralement réalisée après au moins 6 mois.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Gonflement du cou et de la zone sous le menton ; les ecchymoses, **si elles apparaissent**, disparaissent en 1 à 3 semaines
- Engourdissement temporaire de la peau du cou et autour des oreilles
- Tiraillement et induration du cou, et légère gêne en avalant
- Légère douleur, démangeaisons et cicatrices rosées au niveau des incisions
- Irrégularités et zones indurées palpables sous la peau au cours des premières semaines

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Gonflement et induration prolongés** — L'induration du cou et de la zone sous le menton peut durer plusieurs mois ; elle s'améliore avec les massages et le temps.
- **Légère asymétrie et irrégularités du contour** — De légères différences entre les deux côtés du cou ou de petits creux/reliefs sous la peau peuvent persister ; la plupart s'atténuent avec le temps, certains peuvent nécessiter une petite correction.
- **Sérome (accumulation de liquide)** — Accumulation de liquide clair sous la peau ; généralement traitée par ponction à l'aiguille au cabinet.
- **Nécessité d'une retouche** — Environ **5 à 10 patients sur 100** peuvent avoir besoin d'une petite correction en raison d'une plénitude résiduelle, d'irrégularités ou d'une cicatrice.

Situations peu fréquentes

- **Hématome (accumulation de sang dans le cou)** — Survient chez environ **2 à 5 patients sur 100** ; il est plus fréquent **chez les hommes et chez les personnes ayant une tension artérielle élevée** et apparaît généralement au cours des 24 premières heures. Les petits hématomes peuvent être évacués à l'aiguille ; les hématomes importants nécessitent un **retour au bloc opératoire** pour évacuer le sang et arrêter le saignement. Un hématome qui augmente rapidement peut **comprimer la trachée et rendre la respiration difficile** ; cela nécessite un traitement en urgence. Un hématome reconnu tardivement peut altérer l'irrigation sanguine de la peau et entraîner des problèmes de plaie et de cicatrice.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Faiblesse temporaire des mouvements de la lèvre inférieure (rameau marginal de la mandibule / rameau cervical du nerf facial)** — Chez environ **1 à 10 patients sur 100**, un côté de la lèvre inférieure peut paraître asymétrique lors du sourire. La plupart des cas sont dus à un étirement du nerf ou au gonflement et récupèrent spontanément **en quelques semaines à quelques mois**.
- **Fuite de salive / accumulation de salive (sialocèle)** — Chez les patients dont la glande sous-mandibulaire a été réduite, de la salive peut s'échapper de la glande et s'accumuler sous la peau. Cela se résorbe généralement grâce à des ponctions répétées à l'aiguille, un pansement compressif et, si nécessaire, des médicaments ; rarement, un geste complémentaire est nécessaire.
- **Déformation due à un retrait excessif de tissu** — Le retrait d'une trop grande quantité de graisse ou de tissu glandulaire peut créer un creux au milieu du cou, des muscles saillants et un aspect « squelettisé » (déformation en « cou de cobra »). La correction peut nécessiter une greffe de graisse ou une nouvelle intervention ; c'est pourquoi le retrait de tissu est réalisé de manière équilibrée et contrôlée.
- **Cicatrices visibles ou élargies** — Les cicatrices sous le menton et derrière les oreilles peuvent rarement s'épaissir, s'élargir ou changer de couleur. Elles peuvent être traitées par des injections de corticoïdes, un gel de silicone ou une reprise de cicatrice. Si l'incision derrière l'oreille se prolonge jusqu'à la lisière des cheveux, les cheveux peuvent s'éclaircir le long de celle-ci. Si des incisions sont réalisées autour du lobe de l'oreille, le lobe peut rarement paraître tiré vers le bas et vers l'avant ; une petite correction peut être réalisée si nécessaire.
- **Engourdissement prolongé** — La diminution de la sensibilité du cou et autour du lobe de l'oreille peut durer plusieurs mois ; rarement, elle peut être en partie permanente.
- **Infection** — Survient chez **moins de 1 à 2 patients sur 100**. Elle guérit généralement avec des antibiotiques ; rarement, un drainage est nécessaire.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Altération de la vascularisation de la peau et perte de tissu (nécrose)** — En particulier chez les **fumeurs**, les personnes diabétiques et les patients qui développent un hématome, une désunion de la plaie et une perte de peau sur les bords peuvent survenir. La cicatrisation est prolongée, des pansements et parfois une nouvelle intervention sont nécessaires, et une cicatrice permanente peut persister.
- **Lésion nerveuse permanente** — Une faiblesse permanente des mouvements de la lèvre inférieure survient chez **moins de 1 patient sur 100**. Très rarement, les nerfs qui font bouger la langue (nerf hypoglosse) ou qui assurent la sensibilité de la langue (nerf lingual), ou le nerf qui assure la sensibilité du lobe de l'oreille (nerf grand auriculaire), peuvent être atteints.
- **Problèmes des voies respiratoires et difficultés à avaler** — Dans de très rares cas, en raison d'un hématome important ou d'un gonflement marqué, il peut être nécessaire de sécuriser les voies respiratoires en urgence, puis d'assurer une surveillance en réanimation. Des difficultés temporaires à avaler peuvent survenir après la correction des structures profondes.
- **Lésion d'un vaisseau sanguin ou d'un canal salivaire** — Un saignement dû à une lésion des veines du cou ou des problèmes du canal de la glande salivaire sont très rares ; ils peuvent nécessiter un traitement ou un geste complémentaire.
- **Récidive du relâchement** — Au fil des années, le cou peut à nouveau se relâcher avec le vieillissement et les variations de poids ; il s'agit d'un processus naturel, et non d'une complication. Les bandes musculaires du cou peuvent également redevenir visibles avec le temps. Un relâchement marqué précoce est rare.
- **Insatisfaction psychologique** — Malgré un résultat techniquement réussi, une personne peut avoir du mal à s'adapter à sa nouvelle apparence. Discuter ouvertement des attentes avant l'intervention réduit ce risque.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Gonflement, tension ou augmentation de volume marquée d'un seul côté du cou, s'aggravant rapidement**, surtout au cours des 24 à 48 premières heures
- **Difficultés à respirer, modification de la voix, impossibilité d'avaler** ou sensation d'étouffement (appelez le 112 sans attendre)
- **Saignement qui ne s'arrête pas** sous le pansement, ou sang augmentant rapidement dans le réservoir du drain
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, rougeur, douleur ou chaleur croissantes, ou écoulement de pus au niveau des incisions
- **Assombrissement ou coloration violacée à noire** de la peau, ou ouverture de la plaie
- Douleur soudaine et intense, ou douleur qui ne cède pas aux antalgiques
- Essoufflement, douleur thoracique, ou gonflement et douleur d'une seule jambe

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Pendant les 2 premières semaines, dormez sur le dos, la tête surélevée ; évitez de trop fléchir le cou, les mouvements brusques de la tête et du cou et le fait de vous pencher en avant.
- Portez le vêtement de contention/pansement du cou pendant la durée indiquée (généralement 1 à 3 semaines).

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Contrôlez régulièrement votre tension artérielle et n'oubliez pas vos médicaments ; évitez de forcer en poussant, de soulever des charges lourdes et de laisser une toux non maîtrisée.
- Évitez le sport intense, le sauna, le hammam et les douches chaudes pendant les 3 à 4 premières semaines.
- Protégez vos cicatrices du soleil pendant au moins 3 à 6 mois.
- Si vous venez de l'étranger, prendre l'avion est généralement sans danger une fois le drain retiré et les premiers contrôles effectués, en général à partir du 5e au 7e jour.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.

☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ Je comprends que l'intervention n'arrête pas le vieillissement, que le cou peut à nouveau se relâcher avec le temps et que le résultat est limité par la qualité de ma peau, mon poids et ma structure osseuse.
- ☐ Je comprends qu'il est important de maintenir ma tension artérielle sous contrôle et de suivre les consignes postopératoires afin de réduire le risque de saignement (hématome).
- ☐ Je comprends que cette intervention est **à visée esthétique**, qu'elle n'est pas médicalement nécessaire et que j'ai toujours la possibilité de ne pas la faire. J'ai discuté de mes attentes avec mon médecin, et le résultat réaliste pouvant être obtenu m'a été expliqué.
- ☐ Je comprends qu'une symétrie parfaite ou la reproduction exacte de l'apparence d'une photographie ne peuvent être garanties, que le résultat final dépend de la cicatrisation de mes tissus et que, dans certains cas, une intervention de correction peut être nécessaire.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien avec le patient :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.